

07 - 07- Mycoses superficielles - Pr. Hocar

(0:00 - 0:30)

Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le cours intitulé les mycoses superficielles. Les mycoses superficielles sont l'ensemble des micro-organismes fongiques atteignant la couche cornée de l'épiderme, les demi-myqueuses et les myqueuses adjacentes associées aux follicules pileux, mais aussi les fanères. On en distingue les agents fongiques filamenteux comme les dermatophytes, les luvériformes comme les candidoses et les moisissures.

(0:32 - 1:00)

Au terme de ce cours, l'étudiant doit être capable d'énumérer les différents agents mycosiques responsables d'infections superficielles, connaître le profil épidémiologique des différents agents pathogènes responsables et au final savoir diagnostiquer et traiter les infections mycosiques superficielles. Comment on peut définir les mycoses superficielles ? Ce sont des infections dues à des champignons microscopiques. On en distingue trois groupes.

(1:01 - 1:15)

Les dermatophytes, ce sont des champignons filamenteux kératinophiles qui se reproduisent par des spores. Les levures qui se reproduisent par bourgeonnements où ils forment des pseudophylamins. Essentiellement, on distingue le genre *Candida* et *Malassezia furfur*.

(1:15 - 1:32)

Les moisissures sont rarement impliquées dans les infections cutanées mycosiques superficielles. Nous allons commencer par les dermatophytoses. Ce sont des infections cosmopolites de la peau et des fanères et sont dues aux dermatophytes.

(1:32 - 1:45)

Ce sont des champignons filamenteux kératinophiles sans aucune affinité pour les myqueuses ni les tissus profonds. Ils se répartissent en trois genres. Le *Microsporum*, *Trichophyton* et *Epidermophyton*.

(1:46 - 1:56)

On distingue trois modes de transmission. Interhumaine, c'est surtout les dermatophytes anthropophiles. Et puis à partir des animaux, ce sont les dermatophytes zoophiles.

(1:57 - 2:18)

Ou par le sol, ce sont les dermatophytes géophiles. Leur pénétration dans la kératine et leur

extension sont facilitées par l'humidité, la chaleur, la macération des plis, la corticothérapie locale et l'immunosuppression. Ce que vous voyez sur cette diapo, c'est un tableau qui résume les différents types de dermatophytes.

(2:18 - 2:42)

On a le Microsporum, Epidermophyton, le Trichophyton et qu'ils soient anthropophiles, zoophiles ou géophiles. Sur le plan pathogénique, le dermatophyte soit va atteindre la peau, soit il va atteindre une structure pileuse. D'abord, sur le plan zone glabre de peau, on peut avoir une réaction inflammatoire qui est schématisée par les points et les corps rouges.

(2:43 - 3:17)

Cette réaction inflammatoire va se passer au niveau de l'épiderme et va entraîner cette réaction inflammatoire avec les points noirs et du bout de la desquamation. Au niveau de la structure pileuse, on voit les points rouges qui schématisent les dermatophytes, qui vont agir à l'intérieur du follicule pileux et qui vont entraîner une réaction inflammatoire qui va englober toute la structure pileuse et qui va aboutir au final à l'élimination du poil ou à l'arrêt de sa croissance. Nous allons voir maintenant les dermatophytes de la peau glabre en dehors de la ténidie.

(3:18 - 3:36)

Au début, la lésion est les érythématosquameuses, bordures papuleuses ou vésiculeuses, qui s'étendent de façon centrifuge. A la phase d'état, les plaques sont arrondies ou bordures cercinées, érythématosquameuses ou vésiculeuses, avec un centre en voie de guérison. Le prurit et le nombre des lésions sont variables.

(3:37 - 4:03)

Les agents pathogènes peuvent être anthropophiles, zoophiles ou géophiles. Quand le dermatophyte responsable est d'origine animale ou tellurique ou après application de corticoïdique, les lésions deviennent très inflammatoires. C'est une lésion à différencier de l'eczéma numulaire, du psoriasis numulaire et du pityriasis versicolore, vu le caractère érythématosquameux des lésions qui peuvent se présenter sous forme annulaire ou numulaire.

(4:04 - 4:15)

Nous arrivons maintenant au dermatophyte ténidie. Nous allons voir d'abord l'intertrigo interorteil. C'est dû au dermatophyte d'origine interhumaine.

(4:16 - 4:42)

Cela atteint souvent les personnes qui fréquentent les lieux collectifs où les gens marchent pieds nus, favorisant la transmission. Cela atteint généralement les troisième et quatrième espaces qui

sont souvent atteints. Sur le plan clinique, cela peut donner une simple desquamation, une fissure, une couenne blanche, placard érythématosquameux, érythème vésiculeux, voire bulleux à surface rouge, entouré par une collette au niveau interorteil.

(4:42 - 4:51)

Le prurit variable d'une personne à l'autre et les lésions peuvent s'étendre au reste du pied. Les autres plis peuvent être atteints. La peau glabre et les mains peuvent être aussi.

(4:52 - 5:07)

L'intertrigo interorteil peut se compliquer d'hérésipel parce que c'est une porte d'entrée à rechercher, comme on l'a vu dans l'hérésipel. Donc toujours, devant un hérésipel, chercher un intertrigo interorteil. Et bien sûr, il peut aussi se compliquer d'un eczéma déshydrosique.

(5:07 - 5:20)

Donc d'abord traiter l'intertrigo puis l'eczéma. Et bien sûr, examiner bien les patients en cherchant cet intertrigo. Là, pour vous montrer l'aspect d'un intertrigo interorteil chez un jeune sportif.

(5:21 - 5:44)

Là, c'est un autre aspect d'un intertrigo interorteil. On voit l'aspect blanc des lésions interorteil. Chez un patient qui atteint de pied d'athlète, un grand sportif aussi, donc le rôle de la macération qui permet d'entretenir les lésions mycosiques dans cette zone sujette à des infections à répétition.

(5:45 - 6:00)

Toujours dans les dermatophyses des plis, maintenant nous allons voir l'intertrigo des grands plis. Ça atteint généralement les plis inguinaux, ancien eczéma marginal de Hébra, et les plis interfessiers. Les autres plis soma mère, axillaire et abdominaux, peuvent être atteints, mais rarement.

(6:00 - 9:06)

et ça réalise des placards érythématosquameux à partir du pli inguinal et puis sur la cuisse. Secondairement, le centre palli et la bordure restent actives, érythématosquameuses, papuleuses ou vésiculeuses. Généralement, le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l'intertrigo condylosique, le psoriasis dans son atteinte inversée des plis et la dermatite irritative et l'eczéma des plis.

Sur cette photo, vous pouvez voir une lésion érythématosquameuse sur les plis qui s'étendent sur la partie glabre des fesses avec ce contour polycyclique dont la bordure est très bien dessinée. Le centre en voie de guérison, c'est ce qu'on appelle le caractère cerciné des lésions

d'une dermatophytie de la peau glabre. Après l'atteinte de la peau glabre et des plis, on va passer maintenant à l'atteinte des poils, ce qu'on appelle les teintes.

Les teintes sont définies comme des dermatophyties des poils. Elles atteignent essentiellement les enfants en âge scolaire entre 4 et 12 ans. Elles sont rares chez le nourrisson et après la puberté, bien que les teintes existent chez l'adulte.

Les aspects cliniques sont variables en fonction de l'âge en pathogène. On peut en distinguer trois tableaux, les teintes tendantes, les teintes inflammatoires, ce qu'on appelle aussi les carions et les teintes phagiques. Il faut savoir que les teintes guérissent à la puberté, sauf le phallus.

Nous allons voir en premier les teintes tendantes. Ce sont des dermatophytoses cosmopolites du cuir chevelu, touchant surtout les enfants d'âge scolaire et parfois les femmes. La mise en évidence de cheveux cassés courts au-dessus de leur émergence est le signe essentiel permettant d'opposer le diagnostic.

Les teintes tendantes sont responsables de deux types de manifestations. D'abord, les teintes microscopiques. Elles sont dues le plus souvent à *Microsporum canis* après une contamination d'origine animale, le chat, le chien, hamster, parfois lapin, directe ou indirecte.

Parfois, on peut avoir des poils de chat sur un tapis qui explique cette contamination indirecte. Plus rarement, la transmission est interhumaine, due habituellement à *Microsporum longueroni* et se manifeste par la survenue d'une grande plaque, parfois de 2 à 3, erythématosquameuse, arrondie ou polycyclique, dont le diamètre varie de 3 à 6 cm. Tapissées de cheveux blancs grisâtres, cassés courts à leur émergence de 5 mm, s'arrachant facilement.

On peut avoir aussi un aspect d'herpès cerciné de la peau glabre qui peut être souvent associée. L'examen aux lumières d'eau houde donne une fluorescence verte caractéristique. Sur cette photo, on voit une grande plaque alopestique avec des cheveux qui sont coupés à leur émergence.

C'est une plaque unique avec un test de traction positif, aspect très compatible d'une teinte microsporique chez un enfant. Toujours dans les teintes tendantes, nous allons voir les teintes trichophytiques. Elles touchent le plus souvent les enfants.

(9:06 - 13:01)

Ces teintes sont essentiellement dues à des espèces anthropophiles, à contamination interhumaine, notamment le violasson, le sodanès, autres insurances. Elles sont contagieuses et responsables de petites épidémies familiales ou collectivités. Elles se manifestent par la survenue de petites plaques alopestiques squameuses de 0,5 à 2 cm, enfermant des cheveux fragiles, s'occasant à leur émergence.

Le nombre des lésions est multiple. Généralement, ça peut atteindre des petites plaques et la lumière d'eau houde est négative. Là, sur cette photo, on peut voir une petite plaque qui est discrètement squameuse avec une alopiestie.

Donc, c'est des cheveux qui sont coupés à leur émergence de 2 mm. Et bien sûr, un test de traction positif, aspect compatible avec une teinte tendante trichophytique. Toujours dans les teintes, après avoir vu les teintes tendantes, nous allons voir les teintes inflammatoires.

Ce sont des teintes du cuir chevelu de l'enfant, appelé carillon, et de l'adulte, en particulier au niveau de la barbe chez l'homme, ce qu'on appelle le psychosis de la barbe trichophytique. Ils s'y visent surtout en milieu rural et sont dûs principalement aux dermatophytes zoophiles, type Montagrophytes, Gericosome, Equinum et Canis. Et exceptionnellement, trichophytes angiophiles, comme le Microsporum Sporum gypsum.

En fait, tous les dermatophytes responsables de teintes peuvent être à l'origine d'un carillon, comme les trichophytes en violasome osodanaise ou trichophytes en rubran, qui un agent exceptionnel de teintes de cuir chevelu peut être l'agent d'un psychosis de la barbe chez l'homme. Elle se manifeste au début par la survenue d'une plaque erythémato-squameuse circulaire qui évolue vers un macaron inflammatoire surélevé de quelques centimètres de diamètre, généralement 3 à 5 centimètres, bien limité, recouvert de pustules folliculaires, laissant sourdre un pus genâtre avec expulsion des cheveux. L'examen direct révèle un parasitisme ecto-et endotrix en fonction de l'agent.

Il n'y a pas de fluorescence en lumière douce. Sur cette photo, on voit un enfant atteint d'une teinte inflammatoire. Voilà l'aspect du macaron inflammatoire du scalp.

Il est alopietion avec une peau très rouge et issu de pus au niveau des orifices pilaires. Là, cette photo montre un psychosis trichophytique de la barbe. On voit sur la peau non poilue, on a l'aspect erythémateux, légèrement cerciné, polycyclique et au niveau de la moustache, on a une destruction des follicules pileux par des pustules folliculaires.

Sur l'examen clinique, on peut avoir des adénopathies satellites douloureuses, une fièvre modérée peut être aussi observée. Et comme je vous ai dit, la lumière douce est négative. Donc toujours dans les teintes, nous avons vu les teintes tendantes, les teintes inflammatoires.

Maintenant, on va voir les teintes phaviques. C'est une infection qui débute le plus souvent dans l'enfance et s'est vue plus particulièrement dans les zones rurales de l'Afrique du Nord. Elle est due à un trichophyton chenillini, anthropophile très contagieux.

Il est caractérisé par le godet phavique. Il s'agit d'une lésion cupiliforme jaune de quelques millimètres de diamètre, périfolliculaire qui conflue avec les godets voisins pour former la croûte phavique jaunâtre surélevée malodorante. Les cheveux qui traversent les godets sont longs de 6 à 8 centimètres et leur teinte est grisâtre et terne.

En l'absence de traitement, le phavus aboutit à une alopecie cicatricielle. En lumière de Wood, une fluorescence verdâtre est observée sur toute la longueur des cheveux parasités. À l'examen direct, on constate des filaments ou des trajets filamenteux intrapilaires.

(13:03 - 13:27)

Là, sur cette photo, on peut voir l'aspect d'une teinte phavique caractérisée par une lésion cupiliforme jaune de quelques millimètres de diamètre qui va confluer avec les lésions voisines pour former la croûte phavique jaunâtre malodorante. Donc, on voit là l'aspect. Quatrième aspect d'une atteinte trichophytique du poil, c'est la périfolliculite trichophytique.

(13:29 - 15:46)

Elle s'observe chez les femmes qui s'épilent les jambes. Elle se manifeste par des papules folliculaires, des pustules folliculaires et des nodules. C'est l'équivalent de teint inflammatoire, mais à localisation sur les jambes.

Voilà l'aspect des périfolliculites de la jambe. Donc, vous voyez, c'est des lésions qui viennent secondairement après des papules ou des pustules qui emportent le follicule pileux chez une jeune patiente. Le diagnostic positif n'est pas toujours facile.

On doit éliminer certains diagnostics, notamment l'impitigo devant des lésions impitiginisées ou même devant la teinte phavique qui est caractérisée par des croûtes jaunâtres. Les pelades irritées, quand il s'agit d'une pelade, on peut avoir une irritation par des médicaments prescrits par le dermatome, aussi par des médicaments et des produits traditionnels que le patient a appliqué sans consulter son médecin. De ce fait, on peut avoir un aspect de lésions irritées, squameuses, qui peuvent mimer à tout point une teine.

Le psoriasis et l'eczéma, puisque ce sont deux lésions, deux dermatoses qui se caractérisent par des lésions élémentaires irritées, et qui peuvent mimer dans la teinte du cuir chevelu, une teine, surtout la trichophytique. Et en dernier, il y a la folliculite staphylococcique au niveau des jambes et au niveau de la barbe qui peut mimer un psychosis de la barbe trichophytique et aussi une périfolliculite trichophytique au niveau des jambes. Nous arrivons maintenant aux dermatophytoses de l'appareil inguéal.

Elles sont souvent dues à trichophytans ribaumes, à trichophytans interdigitali. Elles se manifestent par trois types d'atteintes. L'onucomycose so-inguéal distale.

Il s'agit de la forme la plus fréquente. Il se manifeste par la survenue d'une hyperkeratose du lit de l'ongle, puis d'un décollement de l'extrémité distale de l'ongle qui devient épaisse, opaque, effrayable. L'ongle a une coloration qui varie du jaune à brunâtre et l'évolution aboutit au bout de quelques années à la destruction et à l'onychodystrophie totale avec une destruction de la tablette inguéale laissant à découvert le lit de l'ongle hyperkeratose.

(15:47 - 19:46)

Deuxième aspect, c'est la leuconichie superficielle. Elle est due souvent à trichophytans interdigitali. Ces formes se manifestent par la survenue d'îlots blanchâtres opaques situés sur la surface de la tablette inguéale qui devient crailleuse, effrayable.

En l'absence de traitement, elles s'étendent pour atteindre la totalité de la surface de l'ongle. Un autre aspect est celui de l'onychomycose so-inguéale proximale. Il s'agit d'une forme très rare due à trichophytans vibrants qui se manifestent par la survenue d'une tache blanchâtre qui débute à l'extrémité proximale et qui progresse au fur et à mesure de la repousse de l'ongle vers son bord libre.

Cette forme est particulièrement fréquente chez les patients atteints du VIH et les immunodéprimés. On arrive maintenant au diagnostic mycologique. Bien que l'aspect clinique est très évocateur, l'examen mycologique est indispensable pour confirmer le diagnostic d'une dermatophysie cutanée.

Le prélèvement doit être fait avant toute prescription dentifangique. Si le patient a déjà reçu un traitement, il faut une fenêtre thérapeutique de quatre semaines en cas de prescription dentifangique locaux et de la grésilofulvine, et trois mois pour les solutions philmogènes et la terbinafine parfois orales. Comment réaliser ce prélèvement mycologique? Donc, il faut une personne qui est habituée à le faire.

Pour l'atteinte de la peau glabre, il faut un grattage des squames à la bordure évolutive de la lésion cercinée. Pour l'étaïne, il faut prélever les squames et les cheveux. Si on a des pustules, il faut prélever le pus.

Pour l'atteinte inguiale, il faut prélever l'ongle à la jonction de l'ongle sain et l'ongle pathologique. L'examen direct doit mettre en évidence les filaments mycéliens et le type de parasitisme pileaire. L'aculture sur milieu de saburo permet l'identification du champignon, mais il demande un délai de quinze jours à deux mois.

Quand est-ce qu'il faut réaliser une étude mycologique? Il faut noter en cas de dermatophysie de la peau glabre, l'étude mycologique n'est pas obligatoire. On peut se baser sur une clinique évocatrice, sur une localisation habituelle, notamment l'atteinte dipli ou l'intertribo-interurteille pour traiter. Des fois, on est amené à prescrire cette étude mycologique.

Donc, il est réalisé en cas de doute diagnostique, en cas d'échec d'un traitement bien conduit qui est pour une autre pathologie. Et cet examen mycologique permet de confirmer ou d'infermer le diagnostic. Qu'en est-il de la dermatophysie inguiale? La confirmation par un prélèvement mycologique est obligatoire.

Pourquoi? Parce que l'examen clinique est insuffisant pour différencier une onychomycose

dermatophysique d'une autre onychopathie, comme le psoriasis et l'eczéma de l'ongle, et une onychomycose à d'autres champignons dont la sanction thérapeutique est différente de la forme habituelle d'onychomycose dermatophysique. Pour les dermatophyses pilaires, le prélèvement mycologique des seins et des cheveux doit être fait avant tout traitement. L'examen direct et la culture devront être faits sur un milieu de savoreau.

L'examen direct permet de préciser le mode de parasitisme et la culture identifie l'espèce. Là, c'est un type de parasitisme pilaire qu'on peut retrouver, soit un schéma hectotrix ou endotrix. Au cours de la teinte microsporique, les cheveux sont engainés de sport, ce qui donne l'aspect de parasitisme hectotrix, c'est-à-dire qu'ils se mettent en dehors de la gaine pilaire.

Les teintes trichophytiques, on a un parasitisme endotrix caractérisé par la présence de sport à l'intérieur du poil. Au cours des teintes inflammatoires, on a un parasitisme endo-hectotrix, donc les deux aspects externes et internes. Et au cours de la teinte phallique, on a un parasitisme endotrix.

(19:48 - 19:59)

On arrive maintenant à la prise en charge des dermatophytoses. D'abord, les moyens dont on dispose, les antimicrocycloquaux. On peut trouver des hémédazolés, ce forme de crème-solution-poudre.

(19:59 - 20:12)

Les différentes molécules existent, ce forme d'éconazole et de kétoconazole. Cycloperoxylamine, ce forme de crème-solution-solution filmogène. La terbinafine, ce forme de crème-solution.

(20:13 - 20:51)

Et l'amorolfine, ce forme de solution filmogène au vernis, surtout pour les tablettes anguillères. À côté des antimicrosiques par voie topique, on a des antimicrosiques par voie générale. On trouve la grésiofulvine.

On ne peut pas dépasser un gramme chez l'adulte. Et chez l'enfant, on ne peut pas dépasser 20 mg par kilo par jour. La terbinafine, 250 mg par jour.

Et le fluconazole, ce forme de 150 mg par semaine. À côté des antimicrosiques topiques et les antimicrosiques par voie orale, il y a des mesures préventives. D'abord, il faut corriger les facteurs favorisants.

(20:51 - 23:29)

Si on a un diabète, il faut le traiter. Si on a une obésité, il faut bien sûr l'améliorer par une bonne hygiène digitale. Et bien sûr, si on a de l'humidité, la pratique d'un sport particulier, il faut bien sûr

éviter tout ce qui est macération et nettoyer et laver après chaque épisode de sport.

Il faut traiter les autres foyers infectieux chez le patient. Il faut supprimer ou désinfecter les foyers de réinfestation, par exemple les peines, les bonnets, les chaussettes, les tapis de vin, et traiter les sujets et les animaux infectés dans l'entourage. Qu'en est-il des indications des dermatophyses de la peau glabre et les plis? Si on a des lésions qui sont localisées, on peut proposer un traitement local, topique, sous forme de crème ou sous forme de spray, selon l'aspect des lésions.

Généralement, les lésions sointantes, on donne souvent les poudres pour assécher les lésions et éviter la macération. Si on a des lésions sèches, squameuses, on peut utiliser des crèmes. Si on a des surfaces poilues, on peut utiliser des solutions ou les sprays.

Généralement, le traitement local doit être poursuivi au moins trois à quatre semaines. Quand on a des lésions diffuses, on peut proposer par oral la grésiophylle durant trois à quatre semaines ou la terbinafine durant deux semaines. Lorsqu'il s'agit de teint, généralement chose qui arrive souvent chez la population pédiatrique, il faut proposer la grésiophylline, par voie générale, à la dose de 20 mg par kilo par jour pendant six à huit semaines.

Traitement qui doit être pris pendant le repas avec des matières grasses comme le beurre, comme l'huile d'olive et associé à ce traitement, par voie générale, à des soins locaux comme des keratolytiques si les lésions sont routeuses ou épaisses ou à des antifongiques locaux se forment de solutions au niveau du scalp. Il faut couper les cheveux juste au voie de l'image des plaques avec des ciseaux pour améliorer le passage des traitements locaux. L'éviction scolaire est discutable quand il s'agit d'une forme interhumaine, vraiment anthropophile.

À ce moment, on peut proposer une éviction scolaire juste le temps que les enfants ou l'enfant prennent le traitement. Et bien sûr, ne pas oublier de désinfecter les bonnets, les peines à l'aide d'une poudre antifongique. Nous avons terminé avec les dermatophytoses et maintenant nous allons voir les levures.

(23:29 - 33:02)

Donc d'abord, on va voir les candidoses cutanéomyqueuses. Il s'agit de l'ensemble des manifestations cutanéomyqueuses, fanériennes, septicymiques ou viscérales dues à des levures du genre Candida. Parmi les nombreuses espèces du genre Candida, certaines peuvent être pathogènes comme le Candida albicans tropicalis ou Guérimonti.

De nombreux facteurs sont susceptibles de favoriser le passage de la levure de l'état saprophyte, blastospore à l'état parasitaire, qu'on appelle forme pseudophylamenteuse. Surtout des conditions physiologiques comme la grossesse, les âges extrêmes de la vie, mais aussi des conditions pathologiques comme l'immunodépression, le diabète, des facteurs iatrogènes, les corticoïdes, l'immunosuppresseur ou même des antibiotiques et des facteurs locaux comme

l'humidité, la macération et l'acidité. Nous allons commencer par les candidoses cutanées et en premier l'intertréaux.

L'intertréaux débute au fond du pli pour constituer une nappe rouge, vernissée, humide, bien limitée, évoluant de façon symétrique. Les contours irréguliers sont marqués par une collerette disquamative blanchâtre avec de petites papilopustules satellites disséminées en poissènes. Les intertréaux des grands plis somamères, axillaires, inguinaux, interficiers sont favorisés par l'obésité, le diabète, les persudations et l'occlusion.

Les intertréaux des plis interdigyto-palmaires touchent avec prédilection les troisième et les quatrième espaces et atteignent souvent les professions en contact répété avec l'eau comme la dermite des ménagères. Les intertréaux interdigyto-palmaires sont beaucoup plus rares. Là, c'est une photo pour montrer les différents aspects d'intertréaux cutanés d'origine candidosique.

Sur la photo à gauche, on a un intertréaux somamère à candida. On voit les enduits blanchâtres au fond du pli avec une bordure mal limitée et des lésions disquamatives périphériques. À droite, on a un intertréaux interdigital à candida.

On voit l'aspect rouge vernissé avec la bordure disquamative bien limitée. Deuxième forme de candidose cutanée, on a la candidose génitofissière ou anogénitofissière. Il touche avec prédilection les nourrissons et débute au niveau de l'anus.

Il s'étend à l'ensemble de la région génitofissière. Pour noter que l'occlusion créée par le port des couches facilite cette extension. Là, vous voyez, c'est un érythème du siège chez un nourrisson de sexe féminin et on voit très bien la collerette disquamative périphérique et des lésions pustuleuses sur peau saine sur un érythème du siège.

Donc, chose qu'on voit assez souvent dans notre contexte pratique, de l'intérêt de montrer une crème antimicrosique pour traiter ce genre de lésions de candidose du siège. On peut avoir aussi une candidose congénitale chez un nouveau-né. Ça peut réaliser un érythème maculopapuleux pustuleux au niveau du tronc et des extrémités.

La contamination est souvent passée en hétéros. Il faut noter que l'évolution se fait vers la disquamation au niveau des extrémités. Toujours dans les candidoses cutanéomyqueuses, nous arrivons aux candidoses vanariennes.

Quand on dit candidose vanarienne, il faut dire onyxis ou périonyxis d'origine candidosique. Le siège est référentiellement au doigt. Souvent, c'est une atteinte des mains.

L'atteinte candidosique des ongles débute par un périonyxis qui se traduit par la survenue d'un bourrelet inflammatoire de la zone matricielle et du repli susanguial sensible à la pression qui peut faire sourdre un liquide purulent. Donc, l'évolution est subaiguë ou chronique dans la pression. L'onyxis candidosique secondaire débute dans la région proximale et chaque poussée

se traduit par des sillons transversaux sur la tablette tandis qu'une teinte jaunâtre, verdâtre, noirâtre apparaît en particulier sur les bords latéraux.

Les facteurs favorisants sont les microtraumatismes comme les soins de manéchure mais aussi le contact permanent avec l'eau et les substances sucrées surtout chez les pâtisseries et pâtisseries ou chimiquement agressives comme les dermites des ménagères. Là, pour vous montrer l'aspect que peut prendre une candidose inguëale, on voit l'érythème tout autour de l'ongle, ce qu'on appelle un périonyxis avec la tablette inguëale qui est secondairement atteinte. À l'appui, on peut voir sourdre un liquide purulent.

Donc là, ce qu'on appelle un périonyxis inguëale d'origine candidosique. Toujours dans les candidoses panariennes, au niveau des pieds, on peut avoir un onyxis primaire avec un début sur le bord libre ou les bords latéraux. L'atteinte pilaire, on peut l'avoir chez les héroïnomanes quand il y a une prise aussi de corticothérapie et chez les patients opérés.

Ça peut donner des folliculites qui siègent surtout au niveau du cuir chevelu ou de la barbe et peuvent s'accompagner d'un oedème du visage, d'adénopathie et de la fièvre. On peut avoir aussi des localisations profondes candidosiques oculaires, endocardiques et ostéoarticulaires. Les candidoses peuvent atteindre aussi les miqueuses.

D'abord, sur la miqueuse bico-pharyngée, ça peut réaliser un mégu aux candidoses pseudomembraneuses aiguës et les diffuse au localisé à une partie de la cavité buccale, peut-être la joue, la langue, le palais, les gencives. L'extension peut se faire vers les piliers de l'amygdale et l'osopharynx dans les formes civères. Il est responsable de sensations de soif, de brûlure, de sécheresse et d'engots métalliques pouvant gêner l'élocution et l'alimentation.

Il débute par une phase érythémateuse avec une miqueuse sèche, lisse et douloureuse. Puis, il survient de petits dépôts blanchâtres d'aspects grumuleux ou crémeux, plus ou moins adhérents. Là, ces deux photos montrent les aspects qu'on peut retrouver au cours d'une candidose buccale.

À gauche, c'est un mygue profuse chez un patient immunodéprimé. À droite, c'est une stomatique érythémateuse à candida. Là aussi, on peut voir une candidose orale avec un aspect pseudomembraneux qui se voit sur le versant miqueux de la lèvre, mais aussi sur le bout de la langue chez un enfant.

Là aussi, un autre aspect d'une candidose buccale avec une glossite atrophique et une chylite angulaire, chose qu'on peut voir aussi dans les suites d'une candidose buccale. Toujours dans les candidoses buccales, la perlèche est favorisée par les troubles de l'articulé dentaire, les appareils dentaires mal adaptés et l'éthique de l'échage. Elle se manifeste par une atteinte érythémateuse, fissuraire, croûteuse et douloureuse du pliocume viscéral qui est parsemée de ponctuations blanchâtres sur le versant miqueux.

Elle est unie au bilatéral, peuvent déborder sur le versant cutané ou les lésions sans érythémateuse crameuse peuvent gêner l'ouverture complète de la bouche. On peut avoir aussi la chylite, il se manifeste par un érythème, un oedème et une desquamation des lèvres avec une sensation de tension, de brûlure et de picotement. Et puis aussi un autre aspect, celui de la langue vilieuse noire.

Le rôle du candidat n'est pas confirmé dans cette forme clinique. Nous sommes toujours dans les candidoses muqueuses et on va voir les candidoses génitales. D'abord la vulvovaginite.

La vulvovaginite à candidat n'est pas une MST, mais une infection opportuniste facilitée par divers facteurs, notamment la grossesse, l'antibiothérapie, le diabète, etc. Le rôle des contraceptifs oraux est controversé. Il se manifeste par un prurite, décolorée, blanchâtre et crémeuse et par une disparonie.

Voici l'aspect qu'on peut voir chez une personne qui a une vulvite candidosique. On va voir des lésions psoriasiformes, érythémateuses, confluentes avec des lésions érosives et des pustules sur les plis, sur la vulve et qui peuvent déborder sur la cuisse. L'examen clinique trouve au cours d'une candidose génitale une muqueuse érythémateuse, parfois érosive, recouverte de dépôt blanchâtre avec oedème de la muqueuse vulvovaginale.

Ces lésions débordent souvent sur la face cutanée des grandes lèvres et sur les plis inguinaux. On peut avoir aussi une cervicite. Toujours dans les candidoses génitales, maintenant on va voir les balanites ou balanopostites.

Le mode de contamination peut être sexuel après un rapport ou traduire l'extension aux organes génitaux. La survenue de ce type d'atteinte doit faire rechercher un diabète. Les lésions débutent au niveau du sillon balanoprucial pour s'étendre sur le gland.

Elles se manifestent par un érythème diffus, plus ou moins soignant, prurigineux, parsemées de papulopustules. Elles deviennent érosives et sont recouvertes d'un enduit blanchâtre. La tuméfaction de l'anoprucial antérieur peut être responsable d'un phimosis.

(33:02 - 36:04)

Un écoulement urethral ou une candidose digestive peuvent être associées. Le diagnostic d'une candidose cutanéomycotique se fait par l'aspect clinique, mais aussi peut être confirmé ou optimisé par le prélèvement cutané qui est réalisé par grattage au niveau de l'enduit blanchâtre et des squames de la périphérie des lésions. En cas d'atteinte inguinale, on peut recueillir les fragments d'ongles et du matériel puriforme des lésions péri-inguales.

La présence de nombreuses colonies de candidats en culture avec la mise en évidence de blastopore et de pseudofilaments à l'examen direct témoignent de la pathogénicité dans ces localisations aux albicans et normalement absence. On arrive à la prise en charge, il convient

avant tout de rechercher et de supprimer dans la mesure du possible les facteurs favorisants. Quand il s'agit d'une candidose cutanée, il est nécessaire en général de mettre en route un traitement local pendant quatre semaines, ce forme d'amphotéricine B ou un dérivé imédazolé en choisissant une forme galénique en fonction de la localisation.

Il convient de supprimer les facteurs favorisants. En cas d'anithe, il convient de réaliser une décontamination digestive. S'il s'agit d'une onychomycose candidosique, il est nécessaire de mettre en route un traitement local pluricotidien par un antifongique local type dérivé imédazolé, infongizone, cycloprixolamine, ce forme de gel ou de solution associée à un traitement antiseptique.

En cas d'échec, l'administration d'un traitement par voie orale type kétoconazole peut être associée au moins jusqu'à disparition du périonexis, c'est-à-dire deux à trois mois. Quand il s'agit d'une candidose génitale, en cas d'épisode aigu, isolé, on prescrit l'association d'un traitement vaginal, ce forme d'ovule ou de crème vaginale associée à un traitement topique qu'on peut appliquer au niveau génital. Le traitement vulvaire repose sur l'application d'une crème ou d'un lait pendant quatre semaines, tandis que la durée du traitement vaginal reste empirique, trois à six jours.

En cas de symptomatologie génitale plus bruyante, il est recommandé d'éviter les ovules trop dosées et de leur préférer les ovules à libération prolongée. Une toilette avec un savon alcalin ou le rinçage avec une toilette avec un savon alcalin et la toilette sanitaire est la seule solution. Il est recommandé mettre un savon alcalin et de l'eau.

Le troisième produit qui est le plus prévu pour le traitement vulvaire est l'antifongique. Les antifongiques en plus d'être des antifongiques sont des antifongiques des microsorbites. Il est recommandé de l'utiliser de l'antifongique en cas de au hydroconazole qui peuvent être proposés.

(36:07 - 36:35)

Comme je viens de le dire, dans le cas de candidose cutanée, on propose des antimicrocycloquaux 2 à 4 semaines si les ondes diffusent cytoconazole 200 mg par jour ou fluconazole 50 mg par jour pendant 15 jours. Quand il s'agit d'une candidose bucovarangée, on peut proposer des antimicrocycloquaux comme gel buccal forme de myconazole ou suspension buvalonfutéricine B-bucostatine pendant 3 à 4 semaines. Si un patient est immunodéprimé, on propose un traitement systémique.

(36:36 - 36:54)

Toujours dans le traitement, quand il s'agit d'une candidose génitale, il faut proposer des antimicrocycloquaux pendant 1,3 à 4 semaines. Chez la femme, il faut associer ses mesures locales à des ovules. En cas de candidose inguiale, il faut associer un traitement local sous

forme de crème et solution filmogène.

(36:54 - 37:10)

Si des lésions diffusent, il faut proposer un traitement général. Après les levures d'origine candidosique, nous allons voir les levures dues à *Malassezia* ferfure. D'abord, le piteriadis versicolore, l'agent pathogène et le *Malassezia* ferfure.

(37:11 - 37:37)

C'est quoi ce *Malassezia* ? C'est une levure lipophile, ça profite de la peau, surtout des régions séborrhiques, cutanées. Les facteurs favorisant souvent, c'est les persudations et aussi les périodes chaudes et humides. C'est une infection non contagieuse et cliniquement, ça peut réaliser des lésions maquilleuses, jaunes chamois, brunes à trois, chroniques à limites nettes, finement squameuses, que l'on peut mettre par le cyndocopeau.

(37:37 - 38:06)

La taille des lésions est variable et peut confluer en grandes plaques polycycliques. Là, vous voyez sur cette photo un aspect de piteriadis versicolore hyperpigmenté chez une personne de 36 ans de sexe masculin. Vous voyez les lésions pigmentées en plaques au niveau du tronc et au niveau du bras qui peuvent confluer en réalisant ces plaques géographiques bien dessinées, évocatrices bien sûr d'un piteriadis versicolore hyperpigmenté.

(38:07 - 38:35)

Sur cette photo, on peut voir des macules achromiques, coalescentes, petites à taille moyenne et qui sont localisées sur le dos et qui sont très évocatrices de piteriadis versicolore dans sa forme hypopigmentée. Le siège électif du piteriadis versicolore, c'est surtout le thorax, les racines du membre. On peut avoir une extension possible à l'abdomen, sur la région pubienne, les cuisses, région cervicofaciale.

(38:36 - 39:10)

Ce qu'il faut noter, c'est que la région palmoplantaire n'est jamais atteinte et à la lumière d'aude, on peut avoir une fluorescence jaune verdâtre. Sur le plan diagnostique, souvent il est clinique, on peut avoir recours à des prélèvements mycologiques par scotch test qui montre à l'examen direct du filament mycélien et du levure en forme de bouteille groupée en grappe de raisin et à la culture sur milieu de savoros qui peut identifier le malaise cyzia fure-fure en 4 à 5 jours. Il faut noter que la récurrence est fréquente, c'est les conditions favorisantes se répètent.

(39:11 - 39:42)

On arrive à la partie traitement, comment prendre en charge un piteriadis versicolore? On a

plusieurs moyens, les antimucositopiques comme les dérivés imidazolés, cyclopyrroxolamine, une à deux applications par jour pendant 2 à 3 semaines. On peut aussi proposer le quitoconazole en monodose. En cas d'échec du traitement local ou de mauvaise compliance, on peut proposer le fluconazole parfois oral 50 mg par jour pendant 7 à 14 jours ou du quitoconazole 200 mg par jour pendant 7 à 14 jours.

(39:42 - 40:15)

Si on a des formes récidivantes, le traitement doit se faire par voie générale, soit du quitoconazole pendant 10 jours, fluconazole 300 mg par semaine pendant 2 semaines. Ce qu'il faut dire aux patients, que c'est une infection bénigne simplement inesthétique, ce n'est pas une maladie contagieuse, elle ne s'attrape pas sur les plages, elle est due à un champignon normalement présent sur la peau, c'est la modification des conditions cutanées locales propres aux patients qui induit le développement du stade pathogène du champignon. C'est pourquoi les rechutes sont possibles, il faut les prévenir.

(40:15 - 40:51)

Les peaux pigmentées peuvent persister et même paraître souvent plus nettes malgré l'efficacité du traitement, cependant, il est réversible et la peau se recoloré en plusieurs mois ou après exposition solaire. Toujours dans les infections liées aux maladies d'hygiène à faire fur, à côté du pétériasis versicolore, on peut avoir aussi les folliculites pétérosporiques. Il existe plusieurs formes, d'abord la forme de l'adulte, c'est une infection de l'adulte jeune, d'âge moyen, elle se manifeste par des papules et des pustules folliculaires au niveau du dos, des épaules, de priorité variable.

(40:52 - 41:23)

Il en existe une forme néonatale qui se caractérise par des pustules de la région céphalique. Le diagnostic est pareil au pétériasis versicolore et le traitement se base essentiellement sur les antimucositopiques locaux, mais la récurrence est habituelle, surtout dans la forme de l'adulte. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une dermatophytose est une infection cutané-fanérienne superficielle fréquente due à des dermatophytes, ce sont des champignons filamenteux, kératinophiles, toujours pathogènes.

(41:24 - 42:02)

Les facteurs favorisants sont généralement l'humidité, les traumatismes locaux, les occlusions du pli, les lésions cliniques sans squameuse, hyperkératosique, vésiculobuleuse aux pieds et aux mains, arrondie ou sous forme de placard circonscrite limitée par une bordure, effet hématophysique ou squameuse d'évolution centrifuge au niveau de la peau glabre et alopecyque au niveau du cuir chevelu. L'examen mycologique est indispensable dans les atteintes fanériennes, notamment les ongles et le cuir chevelu. Les candidoses sont des

infections opportunistes dues à des champignons olivieriformes du genre *Candida*, dont l'espèce *albicans* est responsable de la plupart des manifestations pathologiques chez l'homme.

(42:02 - 42:49)

Le *Candida albicans* existe à l'état saprophyte sur les muqueuses digestives et génitales. Un certain nombre de conditions favorisent le passage de la forme saprophyte à un stade pathogène. Les infections candidosiques les plus fréquentes sont d'ordre muqueux, mais le *Candida albicans* est toujours pathogène lorsqu'il est isolé à partir d'une lésion cutanée.

Le diagnostic il est clinique et la confirmation par une étude mycologique dont les résultats sont rapides et utiles dans les cas atypiques ou certaines topographies ou quand il y a une maladie ou une dermatose sous-jacente. La prophylaxie et le traitement des candidoses ne se réduisent pas à leur traitement par voie locale au général et doivent faire rechercher les facteurs favorisants, particulièrement en cas de forme récidivante. Je vous remercie pour votre attention.